

Guía a la cirugía bariátrica



Realizando la pérdida de peso con cirugía bariátrica

Si usted padece de obesidad mórbida y ha batallado con la pérdida de peso, usted no está solo. Para muchos pacientes obesos con un índice de masa corporal (IMC) de 40 o más (o incluso de 35 si existen ciertas condiciones), la cirugía bariátrica podría ser la forma más eficaz de bajar de peso substancialmente. Existen varios tipos de procedimientos bariátricos que reducen el volumen estomacal disponible para digerir alimentos y / o reducen la cantidad de nutrientes que pueden ser absorbidos.



Muhammad A. Jawad, M.D., F.A.C.S. y Andre F. Teixeira, M.D. ofrecen un programa completo de adelgazamiento a largo plazo el cual incluye asesoramiento y evaluaciones pre-quirúrgica y chequeos después de la cirugía para supervisar tu salud y el éxito de tu pérdida de peso.

¿Soy elegible para la cirugía?

Para lograr los mayores niveles de eficacia y seguridad, el paciente debe cumplir ciertos requisitos para ser elegible para el procedimiento bariátrico.

- El paciente debe tener entre 18 y 64 años de edad. Puede haber otras restricciones de edad, dependiendo del tipo de cirugía.
- El IMC del paciente debe ser mayor o igual a 40; o mayor o igual a 35 si tiene ciertas condiciones médicas graves.
- El paciente debe haber intentado otros programas de pérdida de peso sin resultados positivos o sin poder mantener su reducción de peso.
- El paciente debe haber estado en su nivel actual de obesidad por un mínimo de dos años.

¿Soy candidato?

Los candidatos para la cirugía bariátrica normalmente han padecido de obesidad mórbida por cinco años o más y han intentado bajar de peso a través de medios tradicionales durante un periodo de tiempo prolongado. Desafortunadamente, los métodos más comunes para bajar de peso como la dieta, ejercicios, medicamentos y terapia, simplemente no funcionan para muchas personas. En estos casos, la cirugía puede ser una solución eficaz.

Beneficios de la cirugía bariátrica

Un estudio comprensivo de 10 años realizado por los Institutos Nacionales de la Salud demostró que en el caso de los pacientes con obesidad mórbida, la cirugía bariátrica fue la forma más eficaz de bajar de peso y mantener un menor peso a largo plazo con un porcentaje de éxito excediendo el 80%.

Además, de acuerdo con el estudio publicado en Cleveland Clinic Journal of Medicine, entre los beneficios de salud debido a la pérdida de peso lograda después de la cirugía incluyen una mejora de 95% en la calidad de vida y una disminución de 30% a 40% en mortalidad en los próximos 10 años. El estudio también demostró reducciones substanciales en la diabetes de tipo 2, depresión, enfermedad cardiovascular, hipertensión y asma después de la cirugía bariátrica.

Tipos de cirugía bariátrica

BANDA GÁSTRICA

La banda gástrica es una banda de silicona inflable que se coloca laparoscópicamente alrededor de la parte superior del estómago del paciente. Esto crea una pequeña bolsa que solo puede recibir una cantidad reducida de comida antes de liberarla al estómago e intestinos. Como el paciente se siente lleno después de comer menos, se consumen menos calorías, lo que causa el adelgazamiento.



Como el procedimiento se realiza laparoscópicamente sin incisiones, sin grapas y sin suturas en el estómago o intestinos, la banda gástrica es el tipo de cirugía bariátrica menos invasiva, por lo que habrá menos dolor después de la cirugía y el tiempo de recuperación será menor. Además, la banda gástrica puede retirarse si es necesario y el estómago típicamente vuelve a su forma original.

Un beneficio adicional del uso de la banda gástrica es que puede ajustarse para regular la cantidad de comida que entra al estómago si se necesita cambiar el ritmo de adelgazamiento. Por ejemplo, si una paciente queda embarazada, ella puede tener su banda aflojada para acomodar el desarrollo del feto. De igual manera, podría ser necesario apretarle la banda a un paciente que no adelgaza lo suficientemente rápido.

MANGA GÁSTRICA

Durante este procedimiento, también conocido como “gastrectomía en manga”, se extirpa aproximadamente un 85% del estómago, dejándolo en forma de un tubo angosto o “manga”. El paciente adelgaza porque está limitado a comer entre 1/2 a 1 taza a la vez, lo que significa que se comienza a llenar después de comer porciones de comida más pequeñas. Esta es una solución quirúrgica permanente que se usa más en los pacientes con obesidad mórbida y un IMC superior a 40 o entre 35 y 40 en combinación con otros problemas médicos relacionados.



Con la manga gástrica, se mantiene el funcionamiento del estómago en gran parte, de forma que el paciente puede tolerar muchas de las mismas comidas que ingería antes de la cirugía, solo que en porciones más pequeñas. Debido a que se extirpa la parte superior del estómago, el cual produce las hormonas que estimulan el hambre, el apetito queda suprimido durante unos meses después de la cirugía. Además, el píloro (válvula de salida) se conserva, así que se minimiza el síndrome de evacuación gástrica rápida (paso de la comida sin digerir al intestino pequeño).

Este procedimiento se puede realizar laparoscópicamente en la mayoría de los pacientes y no implica la inserción de ningún dispositivo en el cuerpo. Esto reduce el tiempo de recuperación y la mayoría de los pacientes regresan a su hogar después de solo un día en el hospital.

DERIVACIÓN GÁSTRICA

En el procedimiento de derivación gástrica se usan grapas para crear una pequeña bolsa desconectada del resto del estómago en la cual ingresa la comida. Luego, se reposiciona el tracto intestinal para que el intestino delgado esté unido a la bolsa nueva. Por último, un segmento del intestino delgado que queda unido a la parte inferior del estómago se une al segmento previamente unido a la bolsa. Esto permite que los líquidos digestivos y ácidos producidos en el estómago (que se mantiene

saludable y activo) se mezclen con la comida para permitir el proceso completo de digestión.

El índice de éxito de la derivación gástrica a nivel nacional es de aproximadamente 85%. El procedimiento funciona porque limita la cantidad de comida que se puede ingerir a una o dos onzas a la vez. Luego, una vez que la bolsa se llene, toma unos diez minutos que la comida pase por el intestino delgado. Además, debido a que el estómago ya no puede moler la comida, debe masticarse bien ya que de lo contrario podría ser demasiado voluminosa como para pasar por la apertura al intestino delgado. Esto puede causar molestia severa y vómitos. Estos cambios sirven para que el proceso de ingestión sea más lento, por lo que puede tomar hasta 45 minutos comer dos onzas de proteína con ¼ de taza de almidón, verduras y fruta.



La derivación gástrica también ayuda a adelgazar haciendo desagradable comer en exceso o consumir alimentos de gran contenido calórico, especialmente azúcares. Como la bolsa del estómago va directamente al tracto intestinal, comer demasiado puede activar el síndrome de evacuación gástrica rápida, donde la comida no digerida pasa de la bolsa gástrica al intestino delgado y puede causar dolor, distensión abdominal y cólicos, entre otros síntomas. Con respecto al consumo de azúcar, el tamaño reducido de la bolsa gástrica hace que el cuerpo sea mucho menos tolerante al consumo excesivo de azúcar, que puede causar sudores fríos, náusea, vómitos, diarrea y debilidad general. Estas experiencias ayudan a condicionar al paciente para que sea muy consciente de su alimentación e ingestión calórica general.

CRUCE DUODENAL



El cruce duodenal se realiza en tres partes. Primero, se extirpa una sección del estómago, dejando menos espacio para la ingestión de alimentos. Esto no altera las áreas en las que el esófago o duodeno se unen al estómago. Luego, el duodeno (el segmento del intestino delgado unido al estómago) se separa del resto del intestino delgado y se une a la parte justo encima del intestino grueso. Finalmente, la apertura del intestino delgado separada del duodeno se readjunta al hígado para transportar la bilis y otros líquidos digestivos.

Esto beneficia el adelgazamiento mediante la creación de un aspecto de restricción y malabsorción. Como el volumen estomacal ha sido reducido, la comida lo llena más rápido y el paciente se siente lleno con menos comida. Este es el componente de restricción. Luego, la comida pasa al duodeno y es directamente transportada a la parte inferior del intestino delgado, evitando gran parte del proceso digestivo. Este es el componente de malabsorción. En este punto, las dos secciones fluyen al “canal común” en el que se combina la comida y la bilis/líquidos digestivos.

El procedimiento de cruce duodenal tiene muchos beneficios. En primer lugar, tiene un índice de éxito muy alto, con poco riesgo de volver a aumentar de peso. Es tan exitoso que muchas



de las condiciones asociadas a la obesidad se minimizan o eliminan, incluyendo la diabetes tipo 2 e hipertensión. Además, debido a la conservación del píloro, la válvula que regula el flujo del estómago al duodeno, normalmente los pacientes no tienen el síndrome de evacuación gástrica rápida, que ocurre cuando la comida no digerida pasa a través del intestino delgado.

CONVERSIONES Y REVISIONES

Después de la cirugía bariátrica, los pacientes pueden bajar hasta el 80% de su exceso de peso en los primeros 18 meses. Se espera que la mayoría de pacientes vuelvan a aumentar entre un 10% y 15% de ese peso después de dos años. Un aumento de más del 25% se considera un resultado negativo.

La cirugía bariátrica tiene un alto índice de éxito en el adelgazamiento; sin embargo, los pacientes pueden desarrollar problemas que deben corregirse. Por ejemplo, en algunos casos la bolsa gástrica más pequeña o el estómago reducido pueden dilatarse, lo que con el tiempo permite que el paciente ingiera más comida de lo que podía comer inmediatamente después de la cirugía. La causa más probable de esto es un aumento gradual de la cantidad de comida que ingiere el paciente, lo que estira gradualmente el estómago. Los pacientes con mangas gástricas pueden tener reflujo severo. Si el reflujo no puede tratarse con medicamentos, puede ser necesario cambiar el procedimiento a derivación gástrica.

Mientras que la solución puede variar dependiendo del tipo de la cirugía bariátrica realizada, una segunda cirugía puede ser necesaria para corregir el problema. A veces, la cirugía puede convertirse en un tipo diferente de procedimiento, o la bolsa gástrica puede necesitar ser reformada para reducir su volumen.

El Dr. Muhammad Jawad y Dr. Andre Teixeira ofrecen citas en sus consultorios para hablar de todos estos procedimientos en dos locales prácticos:

Ocala • 2820 SE 3rd Ct., Suite 100 • Ocala, FL 34471

Orlando • 89 W. Copeland Dr. • Orlando, FL 32806

Comience ahora. Llame al 321.842.5088 (residentes de Orlando) o al 800.243.7428 (residentes de Ocala).

